医院员工培训守则

新员工入职 · 医疗安全核心制度 · 心肺复苏 · 院感防控 · 设备维护

文件编号	YZ-TR-2026-01	版本	V1.2
生效日期	2026 年 10 月	修订周期	每年一次
编制部门	医务处 · 护理部 · 院感科 · 医学装备科	适用范围	全院在职员工
密级	院内公开	归口管理	人事科

【合成演示数据】本手册由项目脚本生成，仅用于系统演示与测试，不可用于实际诊疗或管理决策。

一、总则

1.1 目的

为规范新员工入职培训，统一医疗安全底线要求，明确急危重症处置、院感防控与设备管理的基本动作，特制定本守则。

1.2 适用范围

全院在职员工，包括医师、护士、医技、药学、行政、后勤人员，以及进修人员、实习学生和外包驻场人员。

1.3 培训要求

- 新员工须在入职 1 周内完成必修科目，1 个月内完成岗位专项培训。
- 新员工岗前培训不少于 24 学时，在职员工年度复训不少于 8 学时。
- 理论考核 80 分及以上、操作考核合格，方可独立上岗；两次补考仍不合格者暂停独立执业。
- 培训与考核记录由人事科统一归档，保存期限不少于 3 年。

1.4 守则效力

本守则与科室专项操作规程同时执行；两者不一致时，以更严格的规定为准。违反本守则造成不良后果的，按医院相关制度追责。

二、新员工入职与医疗安全核心制度

2.1 入职办理流程

序号	环节	责任部门	时限	需提交材料
1	报到登记	人事科	入职当日	身份证、学历证、执业资格证
2	体检与健康档案	体检中心	3 个工作日内	体检报告、疫苗接种记录
3	岗前培训	医务处 / 护理部	5 个工作日内	培训签到表、考核成绩
4	科室带教	所在科室	1 个月内	带教计划、带教记录
5	授权与考核	医务处	考核合格后 2 个工作日	授权申请表
6	工牌与系统权限	信息科	授权后 1 个工作日	权限申请单

院内文件 · 合成演示数据

2.2 医疗质量安全核心制度（十八项）

以下十八项制度为全院强制执行的底线要求，各科室不得另行简化：

1. 首诊负责制度	2. 三级查房制度	3. 会诊制度
4. 分级护理制度	5. 值班与交接班制度	6. 疑难病例讨论制度
7. 急危重患者抢救制度	8. 术前讨论制度	9. 死亡病例讨论制度
10. 查对制度	11. 手术安全核查制度	12. 手术分级管理制度
13. 新技术和新项目准入制度	14. 危急值报告制度	15. 病历管理制度
16. 抗菌药物分级管理制度	17. 临床用血审核制度	18. 信息安全管理制度

说明：十八项制度的具体执行标准见各制度单行文件；本守则仅作总纲提示，培训考核以单行文件为准。

2.3 培训科目与考核方式

培训科目	学时	考核方式	合格标准
医院文化与规章制度	4	线上答题	≥ 80 分
医疗质量安全核心制度	6	笔试	≥ 80 分
心肺复苏与急救流程	4	模拟人实操	操作评分 ≥ 85 分
医院感染防控	4	线上答题 + 手卫生实操	两项均合格
医疗设备使用与维护	2	现场演示	能独立完成日检
医患沟通与知情同意	2	情景演练	合格
信息系统与病历书写	2	上机操作	完成一份模拟病历

说明：心肺复苏为全员必修，每年复训一次；麻醉、急诊、ICU、手术室人员每半年复训一次。

院内文件 · 合成演示数据

三、心肺复苏（CPR）标准操作与急救流程

3.1 标准急救流程



注：每次按压中断不超过 10 秒；按压者每 2 分钟轮换一次，轮换在 5 秒内完成。

图 1 成人心肺复苏（CPR）标准急救流程（院内版）

3.2 高质量胸外按压要素

要素	标准	常见错误
按压部位	胸骨下半部，两乳头连线中点	位置偏低压迫剑突
按压深度	5~6 cm	深度不足或超过 6 cm
按压频率	100~120 次/分	过快导致回弹不充分
胸廓回弹	每次按压后完全回弹	手不离胸、持续下压
按压中断	每次中断 < 10 秒	频繁摸脉、整理设备
按压通气比	30:2（建立高级气道后改为连续按压）	通气过多、过度通气

3.3 除颤与药物

环节	操作要点	参数 / 剂量
除颤时机	室颤或无脉性室速立即除颤，电极板涂导电糊并压实	双相波 120~200 J
除颤后	立即恢复按压，2 分钟后再次评估心律	不检查脉搏
肾上腺素	静脉推注后用 20 ml 生理盐水冲管	1 mg，每 3~5 分钟一次
胺碘酮	第 2~3 次除颤后仍为室颤 / 无脉室速时使用	首剂 300 mg，可追加 150 mg
可逆病因	按 5H5T 排查：低血容量、低氧、酸中毒、电解质紊乱、低体温；张力性气胸、心包填塞、中毒、肺栓塞、冠脉血栓	每轮循环复查

3.4 团队分工与复苏后处理

- 按压者每 2 分钟轮换一次，轮换在 5 秒内完成，避免疲劳导致深度不足。
- 气道管理者负责球囊面罩通气与高级气道建立；记录者负责计时、给药与事件记录。
- 组长负责决策与除颤，不参与具体操作，确保全局观察。
- 自主循环恢复后：收缩压维持 ≥ 90 mmHg，SpO2 94%~98%，PaCO2 35~45 mmHg，并启动目标温度管理（32~36 ℃，维持 24 小时）。

四、医院感染防控与职业暴露处理规范

4.1 手卫生五个时刻

时刻	指征	方式与时长
接触患者前	进入床单元、握手、查体前	速干手消毒剂 20~30 秒
清洁 / 无菌操作前	置管、换药、注射、导尿前	流动水洗手 40 秒或速干手消毒
体液暴露风险后	接触血液、体液、分泌物、伤口敷料后	流动水 + 皂液洗手 40 秒
接触患者后	查体、协助翻身、更换床单后	速干手消毒剂 20~30 秒
接触周围环境后	接触床栏、床头柜、监护仪后	速干手消毒剂 20~30 秒

4.2 标准预防要点

- 所有患者的血液、体液、分泌物均视为具有潜在传染性，接触时按标准预防执行。
- 预计接触血液体液飞溅时，加戴护目镜或面屏；操作前后执行手卫生。
- 一次性物品不得重复使用；可复用器械使用后立即预处理并密闭转运。
- 发生职业暴露后 2 小时内上报，不得隐瞒或延迟。

院内文件 • 合成演示数据

4.3 职业暴露处置流程

步骤	操作要点	时限	责任人
1 局部处理	锐器伤由近心端向远心端挤出血液，流动水冲洗 5 分钟，75% 乙醇或碘伏消毒；黏膜暴露用大量生理盐水反复冲洗	立即	暴露者
2 上报	报告科室负责人，填写职业暴露登记表	2 小时内	暴露者 / 科室
3 评估	院感科评估暴露源（HBV / HCV / HIV / 梅毒）与暴露程度	24 小时内	院感科
4 预防用药	HBV 暴露按需注射乙肝免疫球蛋白并接种疫苗；HIV 暴露 2 小时内启动阻断用药，最迟不超过 72 小时	越早越好	感染科
5 随访	按病原体潜伏期复查（HIV：4 周、8 周、12 周、6 个月）	按计划	院感科

4.4 医疗废物分类

类别	常见物品	包装与标识
感染性废物	被血液体液污染的棉球、纱布、一次性手套、引流袋	黄色专用袋，标注「感染性废物」
损伤性废物	针头、刀片、玻璃安瓿、缝合针	黄色利器盒，装载不超过 3/4
病理性废物	手术及病理取材后的组织、器官	专用容器，低温暂存
药物性废物	过期、变质或被污染的药品	单独收集，交药学部统一处置
化学性废物	甲醛、二甲苯、含汞器械	专用容器，交有资质单位处置

五、医疗设备日常维护与检查

5.1 日常检查要求

- 每日首次使用前完成外观、电源、报警与附件的四项检查，并填写检查记录表。
- 生命支持类设备（呼吸机、除颤仪、输液泵）须每日测试报警功能，每周核对电池续航。
- 发现异常立即停用、挂「故障」标识、移出诊疗区域，并在设备管理系统报修。
- 设备档案、维修记录、计量检定证书由医学装备科统一保管，保存期限不少于 5 年。

院内文件 · 合成演示数据

5.2 医疗设备日常维护与检查记录表

使用说明：每台设备每日检查后填写；发现异常立即停用、挂「故障」标识并报修；本表每月交医学装备科归档。

日期	设备名称 / 编号	外观与电源	报警与显示	附件与耗材	结论	检查人
		□正常 □异常	□正常 □异常	□齐全 □缺失	□可用 □停用	
		□正常 □异常	□正常 □异常	□齐全 □缺失	□可用 □停用	
		□正常 □异常	□正常 □异常	□齐全 □缺失	□可用 □停用	
		□正常 □异常	□正常 □异常	□齐全 □缺失	□可用 □停用	
		□正常 □异常	□正常 □异常	□齐全 □缺失	□可用 □停用	
		□正常 □异常	□正常 □异常	□齐全 □缺失	□可用 □停用	

5.3 故障报修流程

- 第一步：立即停止使用，断开电源，挂「故障待修」标识，移出诊疗区域。
- 第二步：在设备管理系统提交报修单，注明设备编号、故障现象、发生时间。
- 第三步：医学装备科 2 小时内响应；生命支持类设备 30 分钟内到场，必要时调配备用机。
- 第四步：维修完成后由科室设备管理员验收，记录维修内容与更换配件，方可重新投入使用。

六、培训考核与附则

6.1 考核与上岗

新员工完成全部必修科目并通过考核后，由医务处或护理部核发上岗授权；未取得授权者不得独立值班、独立操作或独立出具报告。

6.2 复训与继续教育

- 全体员工每年完成不少于 8 学时的院内复训，中心肺复苏为必训项目。
- 麻醉、急诊、ICU、手术室人员每半年完成一次心肺复苏复训。
- 新发布或修订的院内制度，应在发布后 1 个月内完成全员培训。

6.3 附则

- 本守则由医务处负责解释，人事科负责培训档案管理。
- 本守则自发布之日起施行，原有相关规定与本守则不一致的，以本守则为准。
- 本守则每年修订一次；遇重大制度调整时及时修订并重新发布。

编制：医务处 · 护理部 · 医院感染管理科 · 医学装备科 审核：医疗质量管理委员会 批准：院长办公会

院内文件 · 合成演示数据